令和8年度
院内災害訓練
台本

令和9年3月6日（土）午前

済生会和歌山病院　災害医療委員会

目次

訓練想定 3

タイムライン 4

部署別台本

新設部門・外来 6

腎センター 8

手術室 9

病棟 10

薬剤部 12

検査科 13

放射線科 14

栄養科 15

リハ科 17

ME他 18

経理・施設設備 19

広報・地域連携 21

医局 22

巻末

全体配役表 23

訓練想定

日時	令和9年3月6日（土）午前。外来と予定手術はありません。
発災	7:30。和歌山市で震度6弱。災害医療体制はレベル3。
院内の状況	停電・断水が続きます。復電しません。自家発電で運転します。
運転時間の目安	フル稼働のとき、地下2階 約12.5時間、本館5階 約23時間、北館 約12時間。節電で延びます。
燃料・給水	依頼先は自治体・酒直。実際の供給は自衛隊。
電子カルテ	使えません。紙で運用します。
通信	PHS、トランシーバーが使えます。北館2階の衛星回線、防災センターのワイドスターが使えます。
場所	災害対策本部：北館会議室1。現地統括本部：本館1階 受付会計前ロビー。トリアージセンター：総合案内前ロビー。集合場所：本館1階 職員食堂。
時間	7:30〜8:00 当直者が対応。8:00 災害医療委員が開始。8:30 一般参加者が登院登録。9:00 傷病者が来院。
傷病者の来院	9:00、9:30、10:00の3回。初めを多く、10:00は少なくします。
本部会議	8:50、9:30、10:30の3回。参加者は、本部長、病院コーディネーター、本部ロジ、現地リーダー、新設部門リーダーです。
トイレ	院内のトイレは使用不可。仮設トイレ3つを設置します。
参加者	傷病者役 約15名、外部役ほか 約5名（看護学生）。
対象外	発熱対応エリアは設置しません。DMATは電話連絡のみ。

タイムライン

時刻	部署	主な動き
7:30	全部署	発災。安全確認と被害確認をして、管理当直へ報告
	全職員	安否確認メールが配信される
8:00	災害医療委員	訓練を開始。仮本部を北館会議室1に設置
	災害医療委員	院内放送で「訓練です」と伝える
	災害医療委員	現地統括本部を設営。安否確認メールの返信を集計
8:30	本部	本部員が到着。院長が本部長を引き継ぐ
	一般参加者	参集。登院登録（記名）
8:35	本部	災害対策本部の設置を宣言。暫定レベル3を宣言
	全部署	初動アクションカードを提出
	新設部門	リーダーを任命。要員を配置
	● 栄養科	4階東へ朝食を運ぶ
8:45	本部	登院人数を集計。応援を割り振る
	全部署	チェックリストを提出。応援人数を申告
	● 経理・施設設備	燃料・給水を手配
8:50	本部	第1回本部会議。レベル3を確定。EMISへ第一報
9:00	新設部門	トリアージを開始。傷病者の第1波
	本部	節水のためトイレを使用禁止とし、仮設トイレの設置を決定
	現地統括本部	院外傷病者が来院し始める。入院が必要な傷病者は、病床を調整
9:15	全部署	余震。安全確認と被害報告
9:30	新設部門	傷病者の第2波。赤ゾーンの人手不足
	本部	第2回本部会議。人員を再配置
	● 病棟	呼吸苦、離室、転倒、所在不明の出来事
9:45	外部役	ワイドスター・衛星回線に入電
10:00	新設部門	定時報告①。EMISを更新
	新設部門	傷病者の第3波（緑・黄が中心）
	● 病棟	機器のバッテリー切れ
10:15	外部役	保健所から、受け入れ・転院搬送の要請
	● 薬剤部	県へ薬剤の搬入を依頼
	● 本部・病棟	家族対応、報道取材、資機材・薬剤の不足への対応
10:30	外部役	燃料・給水の供給連絡。接続口を確認

	● 栄養科	7階多目的ホールで昼食を準備し、配膳
	本部	第3回本部会議。定時報告②
11:00	本部	訓練の終了を宣言。院内放送で伝える
11:00〜11:45	全員	振り返り

台本｜新設部門・外来

配役表

役名	役割	氏名
新設部門リーダー①	新設部門全体の責任者。開始を宣言する	
救急当直看護師①	7:30の当直者	
トリアージ担当①	2人1組でトリアージを行う	
トリアージ担当②	2人1組でトリアージを行う	
トリアージ事務①	専用IDを作り、各ゾーンへ伝える	
緑ゾーン担当①	緑ゾーンの対応	
黄ゾーン担当①	黄ゾーンの観察と治療	
黄ゾーン担当②	黄ゾーンの観察と治療	
赤ゾーン担当①	赤ゾーンの対応	
黒ゾーン担当①	黒ゾーンの対応	

台本

7:30　発災　　救急室

棚が倒れ、救急室は使えない。患者はいない。

救急当直看護師①	安全確認と被害確認をして、管理当直へ報告する
新設部門リーダー①	部署LINEで、スタッフの安否確認と参集を呼びかける

8:30　登院　　現地統括本部

新設部門リーダー①	登院登録をして、本部会議に出る。電子カルテの使用可否と、可能な検査を確認する
新設部門リーダー①	現地統括本部を立ち上げる

8:35　開始準備　　本館1階 ロビー

新設部門リーダー①	外来チェックリストを提出する。役割分担、ブース配置、搬送経路を決める
トリアージ担当①② 黄ゾーン担当①②	ブース用の物品と衛生材料を取りに行く
新設部門リーダー①	トランシーバーを渡し、新設部門の開始を宣言する

9:00 傷病者の受け入れ　病院入口

第1波が来院する。

トリアージ担当①②	入口にブースを設置し、順にトリアージする
トリアージ事務①	紙カルテで専用IDを作り、各ゾーンへ伝える
黄ゾーン担当①②	観察と治療を始める。待機場所を設ける。人数が増えたら再トリアージする
新設部門リーダー①	入院が必要な患者を、ベッドコントロールへPHSで連絡する

9:30 人手不足　赤ゾーン

第2波が来院し、赤ゾーンが満床になる。

新設部門リーダー①	人手の応援を、現地統括本部へ要請する

10:00 定時報告①　現地統括本部

新設部門リーダー①	各ゾーンの状況を報告する

10:00 第3波　トリアージセンター

緑・黄が中心。

トリアージ担当①②	トリアージを続ける

10:30 定時報告②　現地統括本部

新設部門リーダー①	各ゾーンの状況を報告する

台本｜腎センター

配役表

役名	役割	氏名
腎センター責任者①	透析の可否を判断し、本部へ報告する	
透析スタッフ①	安全確認と機器・資材の確認	
透析スタッフ②	安全確認と機器・資材の確認	

台本

7:30　発災　　自宅

透析スタッフ①②	安否を入力する。出勤できる人は出勤する

8:00　開始　　透析室

スタッフは7:45から順に出勤する。外来患者が来院し始める。

腎センター責任者①	8:30の透析開始の可否を判断し、本部へ報告する

8:35　被害確認　　透析室

透析スタッフ①②	機器の作動と破損、透析資材、発電機、貯水量を確認する
透析スタッフ①②	外来透析患者の安否と来院手段を確認する
腎センター責任者①	透析可否と可能人数を、チェックリストで提出する

9:00　透析の実施判断　　透析室

腎センター責任者①	初動アクションカードを提出する
腎センター責任者①	実施する場合は、ベッドと透析条件を調整する
腎センター責任者①	実施できない場合は、患者への連絡と振替施設を調整する

9:15　余震　　透析室

腎センター責任者①	安全を再確認し、透析を続けられるかを検討する

10:30　給水　　透析室

給水の連絡が入る。

腎センター責任者①	透析の実施可否を再検討する

台本｜手術室

配役表

役名	役割	氏名
手術室責任者①	被害をまとめ、本部へ報告する	
手術室看護師①	器械と衛生材料の確認	
手術室看護師②	器械と衛生材料の確認	
中材①	洗浄・滅菌室の確認	
中材②	洗浄・滅菌室の確認	

台本

7:30　発災

手術室

勤務者も患者もいない。前日の手術器械の洗浄が残っている。

手術室責任者①	グループLINEで、スタッフの安否と出勤の可否を確認する

8:30　登院

手術室

中材は8:00に出勤する。

手術室看護師①②	チェックリストに沿って、手術室内を確認する
手術室責任者①	手術に対応できるかを判断する

8:35　被害の報告

手術室

手術室責任者①	手術室の可否を提出し、本部へ報告する
手術室看護師①②	麻酔器は使える。電気メスなどは、電源があれば使える。手洗い場は使えない。記録は紙で行う
中材①②	ウォッシャーとオートクレーブは使えず、新しい滅菌はできない。配盤室は棚が倒れ、器械が散乱している

9:00　緊急手術

手術室

予定手術はない。

手術室責任者①	緊急手術の可否を確認し、特別な手術対応へ進む

9:30　応援

手術室

手術室責任者①	応援に出せる人数を報告する

台本｜病棟

配役表

役名	役割	氏名
病棟統括①	全病棟のとりまとめ	
3階東 看護師①	脳神経外科・糖尿病代謝内科	
3階西 看護師②	循環器・血管外科	
4階東 看護師③	消化器内科・外科	
4階西 看護師④	整形外科	
6階 看護師⑤	回復期リハ	
5階（閉棟中）	アクションカードの動きのみ	

台本

7:30　発災　　全病棟

夜勤者が対応する。

各病棟の看護師	患者、設備、ナースコール、薬剤の安全確認をして、問題なしと報告する

8:35　チェックリスト　　各病棟

エレベーターが止まり、4階東に朝食が届いていない。

病棟統括①	チェックリストを提出する
4階東 看護師③	朝食が届いていないことを、栄養科へ伝える

9:00　病床調整　　各病棟

病棟統括①	入院患者の安全を確認する
病棟統括①	現地統括本部から、入院の相談が入る。各病棟の空床と看護体制を確認して答える

9:15　余震　　各病棟

各病棟の看護師	入院患者の安全を再確認する

9:30 病棟の出来事		各病棟
病棟統括①	応援に出せる人数を報告する	
3階西 看護師②	心不全の患者が呼吸苦を訴える。観察して報告する	
3階東 看護師①	認知症の患者が病室を離れる。探して安全を確保する	
4階西 看護師④	骨折術後の患者が転倒する。観察して医師へ報告する	
6階 看護師⑤	認知症の患者の所在が分からなくなる。探して本部へ報告する	

10:00 設備の出来事		各病棟
各病棟の看護師	医療機器のバッテリーが切れる。予備の電源や機器に替える	

10:15 追加の出来事		病棟・本部
病棟統括①	家族からの問い合わせと、報道機関からの取材に対応する。資機材と薬剤の不足を、本部へ伝える	

台本｜薬剤部

配役表

役名	役割	氏名
薬剤部責任者①	被害と備蓄の状況を、本部へ報告する	
当直薬剤師①	7:30の当直者	
薬剤師②	紙の処方への対応	

台本

7:30　発災　薬剤部

調剤棚・分包機・冷蔵庫は使える。赤いコンセントも使える。

当直薬剤師①	初動アクションカードで状況を確認し、管理当直へ報告する

8:30　登院　薬剤部

薬剤部責任者①	部内の連絡網で安否を確認し、本部へ報告する

8:35　チェックリスト　薬剤部

薬剤部責任者①	チェックリストを提出する
薬剤師②	新設部門と病棟の処方に、紙で対応する

9:00　備蓄の確認　薬剤部

ロキソニンテープだけ、残りが少ない。

薬剤部責任者①	備蓄医薬品を確認し、本部へ報告する

10:15　薬剤の調達　薬剤部

卸は動いていない。

薬剤部責任者①	県に、ロキソニンテープの搬入を依頼する。本部へ報告する

台本｜検査科

配役表

役名	役割	氏名
検査科所属長①	人員の招集と、業務の割り振り	
当直検査技師①	7:30の当直者	
検査技師②	黄ゾーンの血液ガス検査	
検査技師③	赤ゾーンの血液ガス検査と、緊急輸血	
生理検査技師④	心電図検査	
応援の検査技師⑤	割り振られた部門で応援	
応援の検査技師⑥	割り振られた部門で応援	

台本

7:30　発災　検査科

当直検査技師①	連絡網で所属長へ連絡する
検査科所属長①	人員を招集し、病院へ向かう

8:30　登院　検査科

科内の被害はない。

検査科所属長①	初動アクションカードを提出する。残留者は1名以上とし、応援に出せる人数を申告する

8:35　業務の割り振り　検査科

検査科所属長①	チェックリストを提出し、業務を割り振る
応援の検査技師⑤⑥	割り振られた部門へ向かう
検査技師②③　生理検査技師④	新設部門の業務を行う。試薬の避難、毒物・劇物の施錠、試薬の卸への連絡も行う

9:00　検査　黄ゾーン・赤ゾーン・北館

検査技師②	黄ゾーンの血液ガス検査を行い、結果を報告する
検査技師③	赤ゾーンの血液ガス検査を行う。血液型が不明の患者に、O型の緊急輸血を行う
生理検査技師④	北館から機器を運び、心電図検査を行う

台本｜放射線科

配役表

役名	役割	氏名
放射線科責任者①	被害確認と、本部への報告	
当直放射線技師①	7:30の当直者	
放射線技師②	ポータブル撮影とロジ活動	
放射線技師③	ポータブル撮影とロジ活動	

台本

7:30　発災　　放射線科

使える機器はポータブル撮影のみ。一般撮影、CT、MRI、アンギオ、X線TV、骨密度、部門システムは使えない。

当直放射線技師①	安全確認と被害確認をして、管理当直へ報告する
当直放射線技師①	グループLINEで、スタッフの安否を確認する

8:30　登院　　現地統括本部

放射線科責任者①	登院登録をする

8:35　チェックリスト　　放射線科

放射線科責任者①	チェックリストを提出する

9:00　撮影　　ゾーン

放射線技師②③	ポータブル撮影を行う。記録は紙で行う
放射線技師②③	ゾーンのロジ活動を手伝う

9:15　余震　　放射線科

放射線科責任者①	機器と撮影室の被害を再確認する

台本｜栄養科

配役表

役名	役割	氏名
厨房マネージャー①	厨房の判断と、配膳の指揮	
厨房調理師①	7:30の厨房スタッフ	
厨房調理師②	7:30の厨房スタッフ	
配膳の手伝い①	配膳を手伝う一般参加者	
配膳の手伝い②	配膳を手伝う一般参加者	
配膳の手伝い③	配膳を手伝う一般参加者	
配膳の手伝い④	配膳を手伝う一般参加者	
配膳の手伝い⑤	配膳を手伝う一般参加者	
提供先（看護学生）	昼食を受け取る看護学生	

台本

7:30　発災　　厨房

棚が倒れ、厨房は使えない。朝食の第一便は配膳が始まっている。

厨房調理師①②	安全を確保し、火を止める。被害を確認して、管理当直へ報告する
厨房マネージャー①	部署の連絡ツールで、スタッフの安否と参集を確認する

8:30　登院　　厨房

厨房マネージャー①	厨房の状況と調理の可否を、本部へ報告する
厨房マネージャー①	冷蔵庫の食品を移す。非常食（1日目の朝）に切り替えるかを判断する

8:35　朝食の配膳　　4階東

エレベーターが止まり、4階東に朝食が届いていない。

厨房マネージャー①	チェックリストを提出する
厨房マネージャー①　配膳の手伝い①②	4階東へ、朝食を運ぶ

9:15　余震　　厨房

厨房マネージャー①	調理場の火気とガスを再確認する

10:30　昼食の準備

7階 多目的ホール

給水の連絡が入る。

厨房マネージャー①	調理と配膳の見通しを、本部へ報告する
厨房マネージャー①　厨房調理師①②	7階多目的ホールで、非常食（1日目の昼）を準備する。使い捨て食器を使う
厨房マネージャー①	食数、食種、アレルギーを確認して、簡易食札を書く

10:30〜11:00　昼食の配膳

7階 多目的ホール

配膳の手伝い①〜⑤	昼食を、看護学生へ配る
厨房マネージャー①	残数を記録し、トレーを回収する

台本｜リハ科

配役表

役名	役割	氏名
リハ科責任者①	被害を報告し、業務を割り振る	
リハ科スタッフ①	他部門の応援とトイレ対応	
リハ科スタッフ②	他部門の応援とトイレ対応	
リハ科スタッフ③	他部門の応援とトイレ対応	

台本

7:30　発災　　自宅

リハ科スタッフ①②③	安全を確保し、グループLINEで安否を確認する。登院できるかを確認する

8:30　登院　　リハビリ室

リハ科責任者①	リハビリ室の被害を確認する

8:35　報告　　リハビリ室

リハ科責任者①	チェックリストを提出する
リハ科責任者①	スタッフの状況と被害を、本部へ報告する。本部の指示で、業務を割り振る

9:00　トイレ対応　　各病棟・トイレ

リハビリは中止し、他部門の応援とトイレ対応に回る。

リハ科スタッフ①②③	各病棟へ、トイレの水が使えないことを伝える
リハ科スタッフ①②③	災害用トイレの凝固剤とごみ袋を置き、使い方を貼る
リハ科スタッフ①②③	本部の指示で、仮設トイレの設置を手伝う

9:30　応援　　リハビリ室

リハ科責任者①	応援に入れる人数を報告する

台本｜ME他

配役表

役名	役割	氏名
ME担当①	赤ゾーンの機器の配備と、電源・バッテリーの管理	
ME担当②	黄ゾーンの機器の配備と、電源・バッテリーの管理	

台本

8:30　登院　— 現地統括本部

ME担当①②	登院登録をする

8:35　配置　— 現地統括本部

ME担当①②	ME機器の稼働状況を提出する
ME担当①	赤ゾーンに入る
ME担当②	黄ゾーンに入る

9:00　傷病者の受け入れ　— 赤ゾーン・黄ゾーン

ME担当①②	人工呼吸器、モニタ、輸液ポンプを配備し、電源を確保する

9:15　余震　— 院内全体

ME担当①②	機器の転倒と、電源の外れを確認して、現地統括へ報告する

9:30　人手不足　— 赤ゾーン

ME担当①②	機器の整備が済んだら、傷病者の移動補助、記録、物品の運搬を手伝う

10:00　定時報告①　— 現地統括本部

ME担当①②	稼働台数、バッテリー残量、非常電源の接続数を報告する

10:15　赤ゾーンの逼迫　— 赤ゾーン

ME担当①②	現地統括の指示で、黄ゾーンから赤ゾーンへ機器を融通する

10:30　定時報告②　— 現地統括本部

ME担当①②	機器の状況を報告する

台本｜経理・施設設備

配役表

役名	役割	氏名
施設担当①	設備の確認と、燃料・給水の手配	
防災センター担当①	ワイドスターの電話受け	
事務②	本部設営の支援と、物品の調達	

台本

8:30　登院　　現地統括本部

施設担当①　事務②	登院登録をする

8:35　設備の確認　　防災センター

施設担当①	チェックリストを提出する
施設担当①	電気、上下水、医療ガス、建物、発電機を確認して、本部へ報告する

8:45　燃料・給水　　防災センター

復電しない。

施設担当①	発電機の運転時間の目安は、地下2階が約12.5時間、本館5階が約23時間、北館が約12時間。使用電力を控えれば延びる
施設担当①	酒直へ給油を、自治体へ給水車を依頼する。燃料の残りを確認し、高架水槽へ揚水する。院内に節水・節電を依頼する

9:00　本部の支援　　北館2階

事務②	本部の設営を支援し、物品を調達する

9:15　余震　　設備

施設担当①	設備の被害を再確認する

9:45　外部からの入電　　防災センター

ワイドスターに入電がある。

防災センター担当①	電話を受け、現地統括本部へつなぐ

10:30　燃料・給水の供給　　防災センター

供給は自衛隊が行う。

施設担当①	給水口・給油口の口径、タンクの場所、補給の方法を確認して、本部へ報告する

台本｜広報・地域連携

配役表

役名	役割	氏名
登院登録担当①	登院者管理表への記名と集計	
広報担当②	院内放送の文案と、周知文書の準備	

台本

8:00　準備　　現地統括本部

登院登録担当①	登院者管理表を準備する

8:30　登院　　現地統括本部

登院登録担当①	参集者に、登院者管理表へ記名してもらう

8:35　集計　　現地統括本部

登院登録担当①	登院人数と職種を集計して、本部へ報告する
広報担当②	院内放送の文案を、本部ロジへ渡す

9:00　周知の準備　　広報

広報担当②	院内へ知らせる文書を準備する

9:45　周知　　院内

広報担当②	院内放送と掲示で、状況を知らせる

10:00　状況報告　　本部

広報担当②	様式に沿って、建物・設備、患者・職員、ライフライン、診療体制、搬送、周辺・交通、DMAT、その他を報告する

10:30　状況報告②　　本部

広報担当②	内容を更新して報告する

11:00　訓練の終了　　院内

広報担当②	院内放送で「訓練を終了します」と伝える

台本｜医局

配役表

役名	役割	氏名
医局代表①	医師の配置を、本部と調整する	
ゾーンリーダー（医師）①	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	
ゾーンリーダー（医師）②	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	
ゾーンリーダー（医師）③	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	
ゾーンリーダー（医師）④	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	
ゾーンリーダー（医師）⑤	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	

台本

8:30　登院

現地統括本部

医局代表①	登院登録をする

8:35　チェックリスト

医局・当直室

医局代表①	チェックリストを提出する

9:00　医師の配置

現地統括本部

医局代表①	医師を、各ゾーンのリーダーに配置する

9:30　再配置

現地統括本部

医局代表①	医師の再配置を、本部と調整する

全体配役表

区分	部署	役名	主な動き	時刻	氏名
進行		**進行役**	訓練全体の進行と時間管理。終了を宣言する	7:30	
災害対策本部		**仮の本部長（当直医師役）**	仮本部を設置し、院長へ申し送る	8:00	
災害対策本部		**本部長**	設置、レベル、終了を宣言する	8:30	
災害対策本部		**病院コーディネーター**	被災状況を整理して、本部長へ報告する	8:30	
災害対策本部		**本部ロジ**	時系列記録、アルカディアの集計、EMIS入力、院内放送	8:00	
災害対策本部		**本部ロジ補助①**	本部ロジを補助する	8:00	
災害対策本部		**本部ロジ補助②**	本部ロジを補助する	8:00	
現地統括本部		**現地リーダー**	現地統括本部をまとめ、放送を本部ロジへ依頼する	8:00	
現地統括本部		**仮設トイレ設置担当①**	仮設トイレ（テント3つ）を設置する	9:00	
現地統括本部		**仮設トイレ設置担当②**	仮設トイレ（テント3つ）を設置する	9:00	
現地統括本部		**仮設トイレ設置担当③**	仮設トイレ（テント3つ）を設置する	9:00	
各部署	新設部門・外来	**新設部門リーダー①**	新設部門全体の責任者。開始を宣言する	7:30	
各部署	新設部門・外来	**救急当直看護師①**	7:30の当直者	7:30	
各部署	新設部門・外来	**トリアージ担当①**	2人1組でトリアージを行う	8:35	
各部署	新設部門・外来	**トリアージ担当②**	2人1組でトリアージを行う	8:35	
各部署	新設部門・外来	**トリアージ事務①**	専用IDを作り、各ゾーンへ伝える	9:00	
各部署	新設部門・外来	**緑ゾーン担当①**	緑ゾーンの対応	7:30	
各部署	新設部門・外来	**黄ゾーン担当①**	黄ゾーンの観察と治療	8:35	

各部署	新設部門・外来	**黄ゾーン担当②**	黄ゾーンの観察と治療	8:35
各部署	新設部門・外来	**赤ゾーン担当①**	赤ゾーンの対応	7:30
各部署	新設部門・外来	**黒ゾーン担当①**	黒ゾーンの対応	7:30
各部署	腎センター	**腎センター責任者①**	透析の可否を判断し、本部へ報告する	8:00
各部署	腎センター	**透析スタッフ①**	安全確認と機器・資材の確認	7:30
各部署	腎センター	**透析スタッフ②**	安全確認と機器・資材の確認	7:30
各部署	手術室	**手術室責任者①**	被害をまとめ、本部へ報告する	7:30
各部署	手術室	**手術室看護師①**	器械と衛生材料の確認	8:30
各部署	手術室	**手術室看護師②**	器械と衛生材料の確認	8:30
各部署	手術室	**中材①**	洗浄・滅菌室の確認	8:35
各部署	手術室	**中材②**	洗浄・滅菌室の確認	8:35
各部署	病棟	**病棟統括①**	全病棟のとりまとめ	8:35
各部署	病棟	**3階東 看護師①**	脳神経外科・糖尿病代謝内科	9:30
各部署	病棟	**3階西 看護師②**	循環器・血管外科	9:30
各部署	病棟	**4階東 看護師③**	消化器内科・外科	8:35
各部署	病棟	**4階西 看護師④**	整形外科	9:30
各部署	病棟	**6階 看護師⑤**	回復期リハ	9:30
各部署	病棟	**5階（閉棟中）**	アクションカードの動きのみ	7:30
各部署	薬剤部	**薬剤部責任者①**	被害と備蓄の状況を、本部へ報告する	8:30
各部署	薬剤部	**当直薬剤師①**	7:30の当直者	7:30
各部署	薬剤部	**薬剤師②**	紙の処方への対応	7:30
各部署	検査科	**検査科所属長①**	人員の招集と、業務の割り振り	7:30
各部署	検査科	**当直検査技師①**	7:30の当直者	7:30
各部署	検査科	**検査技師②**	黄ゾーンの血液ガス検査	7:30
各部署	検査科	**検査技師③**	赤ゾーンの血液ガス検査と、緊急輸血	7:30
各部署	検査科	**生理検査技師④**	心電図検査	8:35
各部署	検査科	**応援の検査技師⑤**	割り振られた部門で応援	8:35
各部署	検査科	**応援の検査技師⑥**	割り振られた部門で応援	8:35

各部署	放射線科	**放射線科責任者①**	被害確認と、本部への報告	8:30
各部署	放射線科	**当直放射線技師①**	7:30の当直者	7:30
各部署	放射線科	**放射線技師②**	ポータブル撮影とロジ活動	7:30
各部署	放射線科	**放射線技師③**	ポータブル撮影とロジ活動	7:30
各部署	栄養科	**厨房マネージャー①**	厨房の判断と、配膳の指揮	7:30
各部署	栄養科	**厨房調理師①**	7:30の厨房スタッフ	7:30
各部署	栄養科	**厨房調理師②**	7:30の厨房スタッフ	7:30
各部署	栄養科	**配膳の手伝い①**	配膳を手伝う一般参加者	8:35
各部署	栄養科	**配膳の手伝い②**	配膳を手伝う一般参加者	8:35
各部署	栄養科	**配膳の手伝い③**	配膳を手伝う一般参加者	8:35
各部署	栄養科	**配膳の手伝い④**	配膳を手伝う一般参加者	8:35
各部署	栄養科	**配膳の手伝い⑤**	配膳を手伝う一般参加者	8:35
各部署	栄養科	**提供先（看護学生）**	昼食を受け取る看護学生	7:30
各部署	リハ科	**リハ科責任者①**	被害を報告し、業務を割り振る	8:30
各部署	リハ科	**リハ科スタッフ①**	他部門の応援とトイレ対応	7:30
各部署	リハ科	**リハ科スタッフ②**	他部門の応援とトイレ対応	7:30
各部署	リハ科	**リハ科スタッフ③**	他部門の応援とトイレ対応	7:30
各部署	ME他	**ME担当①**	赤ゾーンの機器の配備と、電源・バッテリーの管理	8:30
各部署	ME他	**ME担当②**	黄ゾーンの機器の配備と、電源・バッテリーの管理	8:30
各部署	経理・施設設備	**施設担当①**	設備の確認と、燃料・給水の手配	8:30
各部署	経理・施設設備	**防災センター担当①**	ワイドスターの電話受け	9:45
各部署	経理・施設設備	**事務②**	本部設営の支援と、物品の調達	8:30
各部署	広報・地域連携	**登院登録担当①**	登院者管理表への記名と集計	8:00
各部署	広報・地域連携	**広報担当②**	院内放送の文案と、周知文書の準備	8:35

各部署	医局	**医局代表①**	医師の配置を、本部と調整する	8:30
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）①**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）②**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）③**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）④**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）⑤**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35
特別な役	看護学生	**傷病者役（約15名）**	第1〜3波で来院し、傷病者カードを演じる	9:00
特別な役	看護学生	**外部役（約5名で兼任）**	保健所・県・酒直・自衛隊・DMAT・家族・報道の入電や要請を演じる	8:45